

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no SUS?

O valor da AngioTC no sistema público depende de *onde* ela entra na jornada diagnóstica. Substituir teste não invasivo de primeira linha e filtrar cateterismo já indicado são estratégias distintas — e a evidência aponta em direções econômicas opostas.

Em **3 de julho de 2026**, na 153ª Reunião Ordinária, o Comitê de Produtos e Procedimentos deliberou por **recomendação preliminar desfavorável**, citando incertezas sobre avaliação econômica, impacto orçamentário, capacidade de implementação e delimitação da população elegível. Esta análise responde a esses pontos com bases públicas — CNES, SIA, SIH, SIGTAP, IBGE.

1 · A DECISÃO EM APRECIACÃO

O PICO submetido

paciente sintomático
+ probabilidade pré-teste baixa ou intermediária
+ suspeita de DAC estável
→ AngioTC como **exame de primeira linha**, no lugar do teste funcional

O exame que ela substituiria custa, no SUS, entre R\$ 32,20 (teste ergométrico, 76% dos episódios) e R\$ 788,24 (cintilografia de perfusão). O custo médio por episódio de investigação funcional é de **R\$ 185,46**.

2 · O PROBLEMA ECONÔMICO

Quanto o SUS poderia pagar, e o que os ensaios observaram

A equação de neutralidade **não é a mesma nos dois PICOs**, e essa distinção é decisiva. Quando a AngioTC substitui um episódio funcional, o custo desse episódio é crédito. Quando ela filtra um cateterismo já indicado, a investigação prévia já ocorreu e é comum aos dois braços — cancela, e não pode ser creditada.

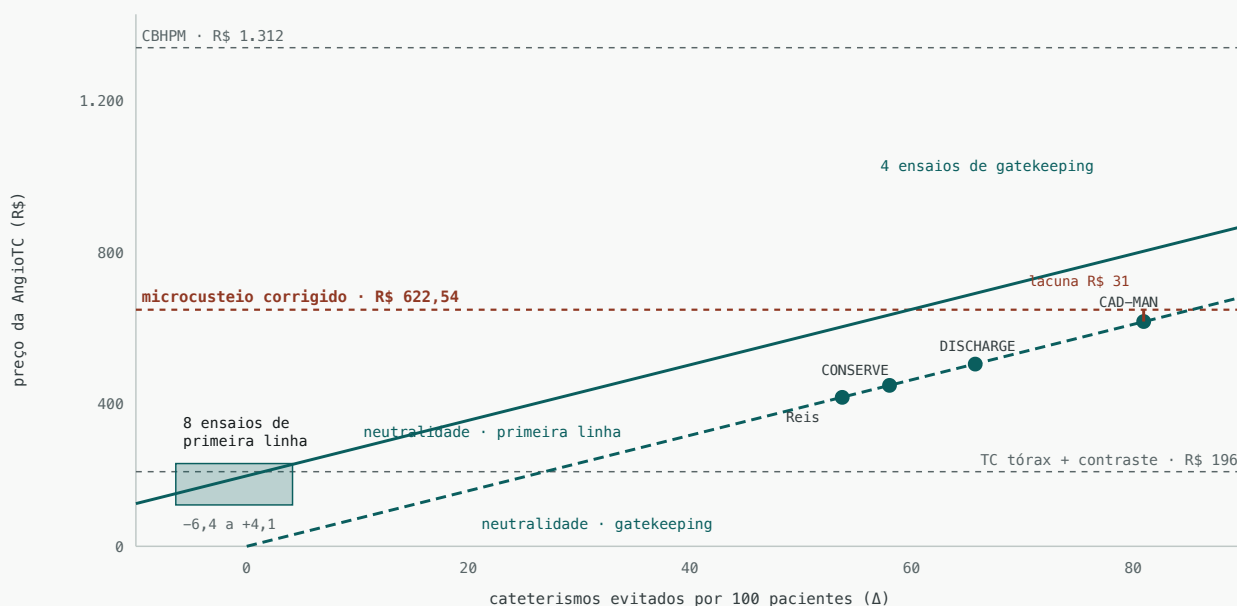
primeira linha

$$P = R\$ 185,46 + (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

gatekeeping

$$P = R\$ 185,46 + (\Delta / 100) \times R\$ 730,14$$

São duas retas paralelas, separadas por R\$ 185,46. Cada ensaio deve ser lido contra a reta do seu próprio desenho.



Cada ensaio está posicionado pelo Δ absoluto de cateterismos que observou e lido contra a reta do seu próprio desenho. Os oito ensaios de primeira linha agrupam-se entre $-6,4$ e $+4,1$, correspondendo a preços de neutralidade de **R\$ 139 a R\$ 215**. Os quatro de gatekeeping situam-se entre $53,7$ e $81,0$, correspondendo a **R\$ 392 a R\$ 591** — três a quatro vezes mais, porém **todos ainda abaixo do custo microcusteado corrigido**. No caso mais favorável, CAD-MAN, restam R\$ 31 por paciente. Pela via de cateterismo evitado isoladamente, nenhum dos dois PICO atinge neutralidade a R\$ 622,54; a distância, contudo, difere por uma ordem de grandeza.

Mesma tecnologia. Outra posição no percurso. Outra economia.

A divergência não é estatística, é mecânica. Depende do que existe no percurso para ser removido.

POPULAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO NÃO INVASIVA

teste funcional

→ [AngioTC](#)

O exame substituído custa **R\$ 32 a R\$ 788**.

Há pouco a remover do percurso para financiar o custo adicional.

POPULAÇÃO JÁ INDICADA A CATETERISMO

cateterismo direto

→ [AngioTC](#)

→ cateterismo apenas se necessário

Há um procedimento caro e invasivo que pode efetivamente sair do percurso.

ENSAIO	COMPARADOR	Δ EVITADOS/100	PREÇO DE NEUTRALIDADE
PROMISE · PRECISE · SCOT-HEART · CAPP · CRESCENT I e II · Foy	não invasivo	-6,4 a +4,1	R\$ 139 – 215
Reis 2022	cateterismo direto	53,7	R\$ 392,09
CONSERVE	cateterismo direto	58,0	R\$ 423,48
DISCHARGE	cateterismo direto	65,7	R\$ 479,70
CAD-MAN	cateterismo direto	81,0	R\$ 591,41

Fonte dos Δ de cateterismo sem doença obstrutiva: IQWiG D22-01 (relatório final, 08/03/2024), Tabela 43, denominador de pacientes randomizados. Os ensaios de gatekeeping recrutam pacientes já referenciados a cateterismo — a taxa de 97% no braço comparador decorre do desenho. **São PICOs distintos e não intercambiáveis.**

4 · CONCLUSÃO

O que a evidência sustenta

Nos ensaios que compararam estratégias não invasivas iniciais, a redução observada na angiografia invasiva foi **ausente, variável ou insuficiente** para sustentar, isoladamente, neutralidade orçamentária aos custos estimados para o SUS. O caso econômico torna-se **três a quatro vezes mais forte** quando a AngioTC filtra pacientes já selecionados para cateterismo — mas, mesmo ali, a via de cateterismo evitado isoladamente não fecha a conta ao custo microcusteado corrigido.

No ensaio mais favorável, a lacuna remanescente é de **R\$ 31 por paciente** — 5%. O modelo inclui deliberadamente apenas um componente de custo. Componentes documentados e ainda não quantificados aqui — menos complicações maiores relacionadas ao procedimento, observadas no DISCHARGE, e diferenças de permanência hospitalar — poderiam plausivelmente fechá-la, mas **isso não foi demonstrado nesta análise**.

Duas ressalvas que o documento completo desenvolve. **Reduzir cateterismo não implica reduzir gasto:** no PRECISE, a economia diagnóstica de 27% foi acompanhada de aumento de 67% no custo de revascularização, com custo total semelhante. E esta é uma conclusão **econômica de curto**

prazo, não clínica — o SCOT-HEART demonstrou redução de morte coronariana e infarto não fatal em 5 e 10 anos.

5 · CAPACIDADE INSTALADA

E se a decisão for positiva, para quantos?

A Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15/01/2026, desmembrou o código de tomógrafo do CNES por número de canais. Em 06/2026, disponíveis ao SUS e em uso:

432 equipamentos ≥64 canais confirmados, em 315 estabelecimentos	83 estabelecimentos com ≥64 canais + hemodinâmica + produção coronariana	26,8% da reclassificação concluída — 2.785 equipamentos ainda sem especificação
--	--	---

12 UFs

sem nenhum estabelecimento no estrato de prontidão

Os 432 são **piso de capacidade documentada**, não estimativa da capacidade real. A portaria dá prazo de três competências: se ele se encerrar antes da apreciação final, a Conitec terá o inventário nacional completo pela primeira vez.

POR QUE OS NÚMEROS SE SUSTENTAM

Inteiramente público, inteiramente reproduzível

- ✓ 395/395 arquivos SIA e 324/324 SIH, 27/27 UFs, competências 01–12/2025, **sem perdas**
- ✓ CNES 06/2026 · SIGTAP 08/2026 · IBGE 2025 · IPCA para correção monetária — todos por FTP público
- ✓ Códigos conferidos linha a linha contra a tabela oficial; Δ dos ensaios extraídos das publicações primárias
- ✓ Nenhum número sem fonte verificável permanece no documento

IMPLICAÇÃO PARA POLÍTICA PÚBLICA

A pergunta talvez não seja *se* o SUS deve ter acesso à angiotomografia coronariana, mas **quais pacientes devem recebê-la primeiro**.

Uma incorporação mal posicionada pode desperdiçar uma tecnologia boa. Uma incorporação mais seletiva pode entregar exatamente o benefício pretendido — e a evidência disponível indica onde.

Escopo. Esta análise não se pronuncia sobre o mérito clínico da angiotomografia coronariana. As conclusões dizem respeito a capacidade de implementação e sustentabilidade orçamentária, nos termos em que o Comitê solicitou esclarecimento.

Título de trabalho: *Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? A National Capacity and Budget-Threshold Analysis*

Prévia de trabalho em andamento · autoria e afiliações a definir · agosto de 2026